

*Direction nationale de la police aux frontières
Sous-direction du soutien et du pilotage territorial
Division du soutien opérationnel*

Paris, le **24 FEV. 2026**

Réf. : DGP/DPNPAF/SDSPT/DSO/SGRH
57449/2026D/322

INSTRUCTION DNPAF N°02-2026

Objet : Rappel de la réglementation et des règles de gestion en matière de congés maladie

I/ RÈGLES DE TRANSMISSION DES ARRÊTS MALADIE

1) Information du service d'emploi et règles de saisie des arrêts de travail dans Portail Agent ou D2

Les fonctionnaires empêchés, informent immédiatement leurs N+1 et transmettent une copie de l'arrêt de travail au secrétariat de leur sous-direction par un moyen de messagerie.

L'agent dispose d'un délai de 10 jours ouvrés pour saisir son arrêt de travail dans le Portail Agent, afin de permettre son enregistrement dans Dialogue 2.

Chaque secrétariat devra transmettre l'arrêt à l'adresse fonctionnelle dnpaf-sdspt-gestionmaladie@interieur.gouv.fr (copie à dnpaf-sdspt-dso-medical@interieur.gouv.fr) en précisant si l'agent a effectué la démarche dans le Portail Agent. A défaut, la SDSPT effectue les démarches pour l'enregistrement dans Dialogue 2.

La DAP ainsi que les services centraux situés hors du site de Garance (OLTIM, UNESI, UCI, DNCTI) se chargent eux-mêmes de la transmission aux services compétents.

2) Règles de gestion pour les apprentis et agents contractuels

Cas particulier : les arrêts maladie des apprentis et des agents contractuels sont enregistrés par le bureau de gestion des PATS dans l'outil Démarches Simplifiées pour l'ensemble des services centraux (hors DAP). Pour ces catégories d'agents, il convient de transmettre les arrêts à l'adresse dnpaf-sdspt-dso-rh-pats@interieur.gouv.fr (copie à dnpaf-sdspt-dso-medical@interieur.gouv.fr).

3) Alimentation et mise à jour de GESTT

GesTT est alimenté par la saisie des arrêts dans Dialogue 2. Il appartient aux secrétariats des sous-directions de vérifier que le compte GesTT de sa population en arrêt est automatiquement mis à jour. En cas de difficulté, il conviendra de signaler rapidement l'anomalie au bureau de gestion du temps de travail de la SDSPT afin d'éviter le blocage des comptes GesTT.

II/ ORGANISATION DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MÉDICALE DES AGENTS DE LA DNPAF

La surveillance médicale des agents de la police nationale relève de deux médecines distinctes : la médecine de prévention et la médecine statutaire

1) La médecine de prévention

La médecine de prévention est chargée de la prévention des risques professionnels et du suivi de la santé de l'ensemble des agents de la PN. Chaque agent doit faire l'objet d'une visite obligatoire par le médecin de prévention. La périodicité de cette visite est fixée à cinq ans maximum, à l'exception des agents travaillant de nuit et les pilotes dont la périodicité est annuelle, ainsi que les escorteurs dont la périodicité est bi-annuelle.

a) pour les agents affectés au sein des services centraux situés à Garance

Le bureau de la protection, du contentieux et de la discipline (BPCD) de la SDSPT se charge de convoquer les agents pour les visites médicales, lors de leur prise de poste ou pour la visite périodique, en fonction des créneaux proposés par le service médical.

Afin d'éviter toute perte de créneau de visite, tout désistement, y compris de dernière minute, devra être signalé sans délai au BPCD, afin qu'un autre agent puisse bénéficier du rendez-vous.

Les secrétariats des sous-directions seront informés des résultats des visites.

A tout moment, un agent peut solliciter un rendez-vous. Il peut, pour se faire, s'adresser au BPCD ou directement auprès du secrétariat de la médecine de prévention.

Il appartient aux chefs de service de prendre en compte, le cas échéant, les préconisations émises par le médecin de prévention.

b) pour les agents affectés au sein des services centraux situés à Lognes

L'infirmière et le médecin in situ convoquent les agents pour les visites périodiques ou les reçoivent sur leur demande.

c) pour les agents affectés à la DNCTI

L'unité des moyens de la DNCTI se charge de convoquer les agents pour les visites médicales, lors de leur prise de poste ou pour la visite périodique, en fonction des créneaux proposés par le service médical de Garance.

d) pour les agents affectés à l'UNESI

Le secrétariat de l'UNESI se charge d'organiser les visites médicales des agents, lors de leur prise de poste ou pour la visite périodique, auprès des services médicaux de Garance et de Lumière.

e) pour les agents affectés au sein de la DAP

Pour les effectifs affectés au sein de la DAP, les services compétents au sein des DAF se chargent de l'organisation de ces visites périodiques avec les services de médecine de prévention localement compétents, qu'ils sollicitent également pour les effectifs nécessitant une visite ponctuelle

2) La médecine statutaire

a) Les visites réglementaires liées à l'aptitude professionnelle

La médecine statutaire vérifie l'aptitude physique et médicale à l'emploi et assure le contrôle des personnels actifs et policiers adjoints, lors du recrutement, après un congé de maladie prolongé, une blessure en service ou un événement particulier comme le désarmement, et lors de la candidature à certains emplois spécialisés.

Tout personnel actif ayant totalisé trente jours de congé de maladie, en une seule fois ou cumulativement sur une période de douze mois consécutifs, doit se présenter lors de sa reprise de service, devant le médecin statutaire. Cette obligation s'applique également à l'issue d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans condition de durée.

Les agents affectés au sein des services centraux sollicitent leur rendez-vous auprès du service médical statutaire via l'adresse fonctionnelle drhfs-sdpasp-smssc@interieur.gouv.fr. Le BPCD reçoit copie du certificat médical d'aptitude à l'issue.

Pour les agents affectés au sein de la DAP, la prise de rendez-vous auprès de la médecine statutaire de la préfecture de police est assurée par les services RH de la DAP.

b) Le dispositif de contrôle et de suivi des arrêts de travail

Les agents placés en congé de maladie ordinaire (CMO) sont obligatoirement soumis à un examen de contrôle, au moins une fois après six mois consécutifs d'arrêt maladie. Les agents placés en congé de longue maladie (CLM) sont soumis à un examen par un médecin agréé au moins une fois par an.

Ces contrôles sont diligentés par le service médical statutaire de la DRHFS ou de la préfecture de police pour les agents affectés à la DAP. Les chefs de service peuvent également solliciter un contrôle à délai plus restreint auprès du BCPD de la DSO/SDSPT ou des services RH de la DAP qui relaieront la demande à la médecine statutaire.

III/ MAINTIEN DU LIEN AVEC L'AGENT ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS FACILITANT LA REPRISE DE SERVICE

Pour permettre le suivi, minimiser le risque d'isolement social de l'agent en arrêt, et ses difficultés à reprendre le travail, des échanges réguliers doivent être mis en place. Ceux-ci peuvent s'opérer selon le calendrier suivant :

Si 2 semaines d'arrêt

N+1 : prendre des nouvelles par mail, sms, téléphone.

Si 1 mois d'arrêt et plus

N+1 : maintenir le lien en continuant à communiquer sur la vie de la structure.

N+1 : informer des possibilités de soutien (médecine de prévention, assistante sociale, psychologue).

RH : informer des incidences sur la paie (jour de carence, CMO à 90 %).

Pour les situations médico-administratives les plus complexes, communication sur les dispositifs de reclassement en lien avec le BEPAM¹ de la DRHFS

15 jours avant la reprise

N+2 et RH : étudier les besoins de l'agent et du service pour déterminer les conditions et le poste de reprise dans certaines situations (puisque le principe est la reprise au sein du même service).

N+1 : échanger avec l'agent pour lui présenter les éventuels changements internes.

N+1 : prévenir les collègues de la date de retour.

RH : demander s'il y a des besoins particuliers pour reprendre (temps partiel thérapeutique, aménagement de poste, ...)

Lors de la reprise

RH : s'assurer de la prise de rendez-vous pour la visite de reprise auprès de la médecine statutaire (après 30 jours de congés en une seule fois ou cumulativement pour les personnels actifs).

N+1 : prévoir un entretien de reprise avec l'encadrant en tenant compte d'éventuelles préconisations mentionnées dans le certificat médical d'aptitude.

Je compte sur l'implication de l'ensemble des chefs de service pour la bonne mise en œuvre du suivi de ces agents en situation d'indisponibilité et leur accompagnement vers un retour en service adapté.

Valérie MINNE

P/o La Directrice Nationale
Le Directeur National Adjoint

Julien GENTILE

¹ Bureau de l'évolution professionnelle et de l'accompagnement managérial

Destinataires

- Madame la directrice nationale,
- Monsieur le directeur national adjoint,
- Monsieur le chef d'état-major,
- Madame la sous-directrice du soutien et du pilotage territorial,
- Madame la sous-directrice de la rétention, de l'éloignement et des procédures,
- Monsieur le sous-directeur des frontières,
- Monsieur le chef du groupement aérien et maritime de la police nationale,
- Madame la cheffe du département numérique,
- Monsieur le directeur de la police aux frontières des aéroports parisiens,
- Monsieur le chef de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants,
- Monsieur le chef de l'état-major opérationnel des frontières,
- Monsieur le chef du service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Madame la cheffe de cabinet.

